

Lactancia materna

- La leche materna es el alimento más indicado los primeros 6 meses de vida exclusivamente, continuando junto con la alimentación complementaria hasta el año o más, según la voluntad de madre e hijo.
- Debe ser exclusiva y a libre demanda
- En los países pobres, los niños que reciben lactancia materna tienen 13 veces más posibilidades de sobrevivir, y amamantar desde el nacimiento reduce la mortalidad del recién nacido en un 45%.
- La leche materna se considera un órgano

Factores que predisponen la decisión de continuar la lactancia

- Sociales
- Educativos
- Laborales
- Rutinas hospitalarias
- Marketing de las fórmulas lácteas
- Pérdida de cultura de la lactancia entre familiares y amigos
- Falta de apoyo de los profesionales
- Cesáreas programadas
- 2 o más condiciones de estrés psicológico materno (episodios anteriores de depresión, insomnio y percepción del parto como algo traumático)

Ventajas de la lactancia materna

Para el lactante

- Reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y muerte durante el primer año de vida
- Disminuye el riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales, respiratorias y urinarias (transmisión de IgA y macrófagos)
- Prevención de obesidad y futuras enfermedades crónicas
- Reducción del riesgo de enterocolitis necrosante del prematuro (ECN).
- Disminuye la incidencia clínica de asma, dermatitis atópica y eccema.

Para la madre

- Favorece vínculo madre-hijo
- Favorece la involución uterina y disminuye la hemorragia postparto.
- Retrasa la ovulación.
- Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario premenopáusico.
- Mayor comodidad por la ausencia de preparación y manipulación.
- Ahorro económico.
- Ayuda a perder peso tras el embarazo.

Técnicas de lactancia

1. Agarre

Todo el cuerpo recién nacido esté de frente a la madre, con la cabeza bien alineada al pecho.

Introducir gran parte de la areola en la boca del niño.

La barriga del niño debe contactar con la de la madre, posición de ombligo con ombligo.

La boca debe estar abierta, el labio inferior hacia fuera, las mejillas aplanadas cuando succiona (no hundidas) y la nariz y el mentón pegados al pecho.



2. Posturas

Posición de crianza biológica.

- Más indicada los primeros días o cuando haya problemas de agarre.
- La madre se sitúa recostada boca arriba y el bebé boca abajo. Se desarrollan los reflejos de búsqueda y gateo.



Posición sentada.

- Puede ser más cómoda con elevación de los pies.
- El tronco del bebé debe estar de frente y pegado al de la madre, que sujetará con la mano su espalda apoyando la cabeza en el antebrazo.



Posición acostada.

- La madre se sitúa acostada de lado, con el bebé también acostado de lado.
- Cómodo para las tomas nocturnas.



Posición invertida o balón de rugby.

- Con el niño por debajo de la axila de la madre, con las piernas hacia atrás y la cabeza a nivel del pecho.
- Cómodo para amamantar gemelos o prematuros.



Posición de caballito.

- Estando la madre sentada, se sitúa el bebé sobre una de las piernas y contactando el abdomen del bebé con el de la madre.
- Útil en el caso de grietas, reflujo gastroesofágico importante, prematuros, labio leporino, mandíbula pequeña y problemas de hipotonía.

**Síndrome de posición inadecuada**

- ★ Mala posición -> deficiente succión -> Generación de grietas -> Dolor al amamantar y tomas cortas -> Mayor consumo de carbohidratos y pocas grasas (sensación de plenitud deficiente) -> Cólicos (por mayor consumo de lactosa) = LACTANCIA DEFICIENTE

Puntos clave para la lactancia materna:

- Amamantar pronto, cuanto antes mejor. La primera toma debe realizarse en la misma sala de partos dentro de los primeros 20 minutos de vida
- Ofrecer el pecho a menudo día y noche
- Asegurarse que el bebé succiona eficazmente y que la postura es correcta
- Permitir que mame del primer pecho lo que desee hasta que lo suelte, después ofrecer el otro
- Cuanto más mame el bebé, más leche producirá la madre
- Evitar los suplementos de fórmulas lácteas y agua
- Evitar el chupete los primeros días hasta que la lactancia esté establecida
- El llanto no siempre significa hambre
- Es importante que la madre descanse y se cuide
- Ofrecer apoyo de grupo de lactancia materna si la madre lo necesita

Los 10 pasos para una lactancia materna eficaz según UNICEF:

1. Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud.
2. Capacitar a todo el personal de salud, de forma que esté en condiciones de poner en práctica esa política.
3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna y la forma de ponerla en práctica.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al alumbramiento.
5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactancia incluso si han de separarse de sus hijos.
6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados.

7. Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día.
8. Fomentar la lactancia materna a libre demanda.
9. No dar chupetes a los niños alimentados al pecho.
10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica.

NOTA:

- A partir del primer día, lo habitual es que mamen unas 8-12 veces al día.
- El calostro constituye “la primera vacuna”, pues en las primeras 24 horas el recién nacido recibe unos 300 mg de IgA secretora. También, tiene un efecto prebiótico, favoreciendo el crecimiento de lactobacilos e impidiendo el de bacterias patógenas y favoreciendo el peristaltismo intestinal.
- El estómago del bebé tiene poca capacidad y en las primeras 24 horas pueden tener suficiente con 1,5 mL por toma cada 2-3 horas.
- Tras la subida de la leche, a partir de las 48-72 horas después del parto, la mayoría de los bebés suelen mamar entre 8 y 12 veces al día.
- La leche cambia de composición durante la toma, al principio es rica en agua y azúcar y gradualmente aumenta su contenido en grasa que sacia al bebé.

Datos que confirman un buen aporte lácteo	Datos de alarma
→ Pérdida fisiológica de peso del 6-10% a los 3-4 días, que recupera hacia los días 10-14 y con aumento posterior de más de 20 g al día. → Niño activo, succión vigorosa y relajado al finalizar la toma. → Tras una succión rápida inicial, esta se enlentece y se observa deglutir, la madre nota que sale leche y se le vacía el pecho. → Succionan vigorosos hasta 10-15 minutos. → Moja 4-6 pañales al día, a partir del 4º día. Deposiciones blandas: 5-6 al día o cada 2-3 días, pero abundantes. ★ Indicadores de que el bebé toma leche materna: hipertrofia de músculos buccinadores y callo en labios	• Factores de riesgo de fracaso: prematuros, nacimientos múltiples, los que son separados de sus madres por razones médicas, mujeres con pezones planos o invertidos o malformaciones del bebé • Pérdida ponderal más de 3-4 días o incremento lento sin recuperación del peso de nacimiento a los 12-14 días • Signos de deshidratación (boca seca, ojos hundidos, piel seca, ictericia) • Lactante hiperalerta, hambriento o letárgico e indiferente • Queda dormido tras escasas succiones al pecho • Disminuye la diuresis y el volumen de las heces • Signos de mala posición: boca muy cerrada, alejado del pecho, pezón dañado o niño que succiona muy

	rápido, mucho tiempo sin llegar a saciarse o sin aumento de peso
--	--

Complicaciones de la lactancia materna:

- Ingurgitación mamaria
- Obstrucción de un conducto lácteo
- Mastitis

Fármacos que limitan la lactancia materna:

- Antineoplásicos
- Drogas de abuso
- fenindiona
- amiodarona
- derivados de la ergotamina
- anfetaminas
- ioduros
- nicotina a altas dosis
- Grandes dosis de cafeína (más de 6 tazas al día)
- Alcohol

Factores que limitan la lactancia materna	
Por parte de la madre	Por parte del bebé
Baja producción de leche materna por: • deshidratación • desnutrición • patología endocrina (hipotiroidismo, deficiencia de prolactina y sx de sheehan(hipoxia hipofisaria por hipovolemia)) • uso de fármacos (anticonceptivos, levodopa, bromocriptina) • alteración del reflejo de eyección (fatiga, dolor, estrés, aversión a la lactancia, tabaco, alcohol y opiáceos)	Baja ingesta de leche materna producida por: • tomas cortas e infrecuentes • hipotonicidad • prematuridad • hipoxia • trisomías • hipotiroidismo • problemas anatómicos (labio leporino, paladar hendido, anquiloglosia, atresia de coanas y micrognatia) • aumento de pérdidas (patología digestiva obstructiva, malabsorción y alergias alimentarias) • aumento de las necesidades (cardiopatías, hiperactividad por alteración del sistema nervioso o consumo de metilxantinas) Niños dormilones: • lactancia intensiva (disponibilidad 24 hrs, exclusividad materna) • exprimir la leche al alimentarlo • exprimir la leche al alimentarlo • posición de bailarina / caballito • uso de galactogogos (metoclopramida / domperidona) • reducir complementarios

Alimentación complementaria = ablactación

- A partir de los 6 meses
- Inconvenientes antes:
 - ningún beneficio
 - interfiere con la absorción de hierro y zinc
 - Aumenta la morbilidad

Contraindicaciones de la lactancia materna:

- Negativa de la madre.
- Galactosemia y déficit congénito de lactasa.
- Consumo de fármacos contraindicados.
- Consumo de drogas de abuso.
- Madre con absceso mamario.
- Madre con lesión activa de herpes simple (HSV-I) mamaria.
- Madre afectada por tuberculosis activa bacilífera no tratada.
- Madre con varicela 5 días antes o 2 días después del parto
- Madre con enfermedad neurológica u orgánica grave.
- Madre VIH positiva.
- Madre seropositiva a retrovirus (HTLV-I, HTLV-II) o brucelosis no tratada.
- Madre afectada por hepatitis B y C*

Lactancia artificial

- Un gran número de niños seguirán una lactancia mixta o artificial, por lo que es preciso conocer las características de las fórmulas artificiales.
- 30% de los lactantes no toman leche materna.
- Lactantes >6 meses el 50% NO toman leche materna.

¿Qué es la fórmula para lactantes?

★ **Definición:** alimento adecuado para sustituir parcial o totalmente a la leche humana, cubriendo los requerimientos nutricionales del lactante.

★ **Tipos:**

- de iniciación: para el lactante durante los primeros 4-6 meses de vida.
- de continuación: como parte de un régimen de alimentación mixto desde el 4-6 mes de edad

→ **Requerimientos:**

- ◆ Se establece la energía que debe aportar **(64-72 kcal/100 ml)** por semejanza con la media de la leche materna.
- ◆ 3.6 cal por 1 g de carbohidrato
- ◆ 9 cal por 1 g de grasa
- ◆ 7 cal por 1 g de alcohol

NOTA:

Suplementar las fórmulas con **alfa lactoalbúmina**, principal

seroproteína de la leche humana, permite trasladar a las fórmulas artificiales su actividad biológica y hacer el perfil proteico más similar.

Un bebé necesita entre 100 a 150 kcal para generar un crecimiento.

Leches de crecimiento	Fórmulas de continuación	Fórmulas de iniciación
- Niños de 1 a 3 años. - Son fórmulas de continuación modificadas parcialmente. - No es necesario añadir: ácido araquidónico, eicosapentaenoico, oligosacáridos probióticos, simbióticos, fosfolípidos como fuente de PUFAs, nucleótidos ni otros elementos (taurina, carnitina, inositol, colina) - Indicado en niños cuya alimentación se caracteriza por el aporte excesivo en proteínas y energía, y por la ingesta baja de: ácido linolénico, ácido docosahexanoico, hierro, vitamina D e iodo. - Aporte energético: 65-77 kcal/100 ml → AHA: no las recomienda.	- a partir del 4to o 6to mes - Contienen: mayor densidad calórica, mayor cantidad de proteínas, calcio y fósforo y deben estar suplementadas con hierro. - Mayor aporte de vitamina D y calcio. - No es necesario añadir: ácido araquidónico, eicosapentaenoico, oligosacáridos probióticos, simbióticos, fosfolípidos como fuente de PUFAs, nucleótidos ni otros elementos (taurina, carnitina, inositol, colina) - Aporte energético: 60-70 kcal/100 ml → ESPHAGAN recomienda que tenga: - Menos proteínas y calorías. → AAP: - NO tienen fórmula de continuación, fórmula única para el primer año de vida	- durante los primeros 4 a 6 meses - Aporte energético: 60-70 kcal/100 ml - Se añade: ácido araquidónico, eicosapentaenoico, oligosacáridos probióticos, simbióticos, fosfolípidos como fuente de PUFAs, nucleótidos y otros (taurina, carnitina, inositol, colina)

Tipos de fórmulas			
Fórmula	Uso	Contraindicación	Contenido
Fórmulas de aislado de proteína de soja Fórmula para todo el primer año de vida	Alergia a las proteínas de la leche de vaca mediada por IgE. Galactosemia. Intolerancia primaria o secundaria a la lactosa -> deficiencia en lactasa (transitoria)	prematurus prevención del cólico del lactante enfermedad renal (hidronefrosis)	- Deficiencia de metionina - Deficiencia de carnitina - Alto contenido de fitatos - Alto contenido de Mg y aluminio - Se debe de suplementar con hidratos de carbono, hierro y zinc Ya vienen hidrolizadas para evitar o reducir alergia a la fórmula de soja

	Dietas sin proteínas animales por razones religiosas o éticas.		
Leche de vaca*	NO ES ADECUADA DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA	Primer año de vida: aumenta riesgo de anemia ferropénica en el lactante Genera diarrea, malabsorción y desnutrición	• Carga excesiva de solutos • Deficiencia de hierro y ácidos grasos esenciales (ácido docosahexaenoico (DHA)) • Deficiencia ácido linoleico y linolénico
Fórmula antirregurgitación *Para problemas más importantes por su frecuencia que por su gravedad *le agrega AR al nombre	Lactante con desmedro causado por la excesiva pérdida de nutrientes asociada a las regurgitaciones.	Lactantes sanos regurgitadores, que crecen adecuadamente.	• Caseína (espesante) aumenta la viscosidad y disminuye regurgitación, se obtiene de la harina de semilla de algarrobo, del arroz y del almidón de maíz. • Butiratos (fuente de energía para el enterocito) • Menor cantidad de grasas y ácidos de cadena larga (enlentecen vaciamiento gástrico)
Fórmulas antiestreñimiento *Tienen AE en el nombre	Lactantes con tendencia al estreñimiento	Lactantes sanos	• 45% de ácido palmítico en posición beta (similar a las grasas de la leche humana) • Magnesio (efecto laxante -> estimula colecistoquinina) • Oligosacáridos (galacto y fructooligosacáridos) con la finalidad de lograr una flora bifidogénica -> deposiciones más blandas
Fórmulas anticólico y fórmulas confort *tienen en el nombre AC	Lactantes que presentan cólicos o molestias abdominales en lactantes sanos	Pacientes con alergia o intolerancia	• Proteínas parcialmente hidrolizadas (facilitan digestión) • Menor cantidad de lactosa que es sustituida por maltodextrina (maltosa) -> (reduce exceso de gas producido por la fermentación colónica de la lactosa) • Ácido palmítico en posición beta. • Fructo-oligosacáridos (efecto prebiótico en intestino delgado)
Fórmulas saciantes	Lactantes "tragones"		• Hidratos de carbono de absorción lenta y un perfil lípido (sensación de saciedad)

			Concentración mayor de triptófano e hidratos de carbono en la fórmula de noche (favorecen conciliación del sueño)
Fórmulas sin lactosa sin disacáridos	Intolerancia secundaria (Infecciones, procesos inflamatorios, cirugías) Déficit de lactasa (1 en 60,000) Galactosemia, siempre que la fórmula no contenga trazas de lactosa. (1 en 40 a 60 mil, común en nómadas irlandeses)	Gastroenteritis aguda en niños sanos.	- dextrinomaltosa o polímeros de glucosa como hidrato de carbono - Resto de la composición es similar a una fórmula adaptada NOTA: Efectos de la lactosa - Carbohidrato principal de la leche materna - facilita la absorción de calcio - Participa en la producción de galactocerebrósidos
Fórmulas hidrolizadas sin microproteínas	Fórmulas de alto grado de hidrólisis (F-AGH): Tratamiento de niños con alergia/ intolerancia a la PLV, sin malabsorción ni desnutrición. Suplemento en la alimentación de los niños con lactancia materna y con alto riesgo de alergia a la PLV. Tratamiento de prueba, durante 2-3 semanas, en niños con cólicos de lactantes severos.		- Se obtienen a partir de la caseína, de las proteínas del suero o de ambos tipos de proteínas de la leche de vaca. - Péptidos con peso menor a 5.000 Daltons
	Fórmulas de bajo grado de hidrólisis (F-BGH): Prevención de dermatitis atópica Son usadas para cólicos pero no se recomienda	Tratamiento de la alergia/intolerancia a la PLV	Se obtienen a partir de la caseína, de las proteínas del suero o de ambos tipos de proteínas de la leche de vaca.
	Fórmula semielemental (DSE): Tratamiento de los niños con intolerancia/ enteropatía por proteína de leche de vaca (PLV), especialmente en niños menores de 6 meses.	Puede producir diarrea osmótica, y alta carga renal de solutos. → deposiciones verdes, líquidas y con grumos.	- Modificación composición de carbohidratos y grasas - Dextrinomaltosa/polímeros de glucosa (sustituye lactosa) - Aceite MCT (sustituye lípidos) - Péptidos con peso menor a 5.000 Daltons

	Tratamiento de pacientes con problemas digestivos: síndrome de intestino corto, fibrosis quística, etc. Tratamiento de la malnutrición grave secundaria a diferentes patologías (cardiopatías, procesos oncológicos...)		Alto contenido en aminoácidos azufrados (mal sabor a la fórmula). SON AMINOÁCIDOS
--	---	--	--

Estreñimiento en el lactante

Deposiciones normales:

- Recién nacido es de 4-6 al día
- Alimentados con leche materna: 10-12 deposiciones en un día o, por el contrario, deposiciones cada 3-5 días pero de consistencia blanda y que no se acompañan de esfuerzo defecatorio

Estreñimiento:

Se prolonga durante al menos 8 semanas y cumple dos o más de los siguientes criterios:

- Menos de 3 deposiciones a la semana.
- Más de un episodio de incontinencia fecal.
- Heces voluminosas en recto o palpables en el abdomen.
- Heces voluminosas que obstruyen el inodoro.
- Posturas retentivas y comportamientos de evitación de la defecación.
- Defecación dolorosa.